

■ 파이프라인 사업성 진단 보고서 의뢰일 2026. 9. 23. · 발행일 2026. 9. 25.

LMB-201은 IND 제출까지 현재 자금으로 도달합니다. 첫 임상 결과까지는 두 차례의 추가 조달이 필요합니다.

(주)루미어스바이오(가상) · 항-CLDN18.2 항체-약물 접합체(ADC) · CLDN18.2 양성 위암·위식도접합부 선암 2차 이상 ·
비임상 단계(GLP 독성시험 진행 중)

런웨이

15.8개월

가용 현금 49억 원 ÷ 월 소진 31억 원
현금 소진 예상 2028년 1월

IND 제출까지 자금 총족 비율

1.98

양호 1.5 이상이면 양호
필요 기간 8개월 대비

P1 완료까지 자금 총족 비율

0.38

미달 추가 조달 2회 필요
필요 기간 41.4개월 대비

ADC · P1 진입 후 승인까지

10.8%

BIO 2021, 184건 기준
고형암 전체 기준 4.6%

요약

본 보고서는 귀사의 LMB-201을 현재 설계안(설계안 A)대로 개발할 경우의 사업성을 임상, 재무, 시장, 규제, 특허, 경쟁 동향의 여섯 영역에서 검토한 결과입니다. 결론부터 말씀드리면, 현재 보유 자금은 IND 제출까지는 충분하나 기술이전 목표 시점인 P1 완료까지는 부족하며, 위암 시장에서는 같은 표적의 선행 자산 대비 차별점을 입증하는 것이 사업성의 핵심 과제로 판단됩니다.

자금 측면에서 가용 현금 49억 원은 IND 제출 목표 시점(2027년 5월)까지 소요될 운영비 약 25억 원의 두 배 수준이며, IND 제출 시점에 약 24억 원이 남을 것으로 추정됩니다. 그러나 항암 P1의 업계 평균 소요 기간(2.7년)을 적용하면 P1 완료까지 41.4개월이 필요하고, 이 구간의 자금 총족 비율은 0.38에 그칩니다. 시리즈A 150억 원이 계획대로 2027년 4월에 마무리되더라도, P1 진행 중 두 번째 조달을 시작해야 하는 구조입니다.

임상 측면은 양호합니다. CLDN18.2 발현으로 환자를 선별하는 설계는 성공확률을 높이는 요인으로 보고되어 있으며, ADC의 P1 진입 후 누적 승인확률 10.8%는 고형암 전체 평균 4.6%를 상회합니다. 반면 시장 측면에서는 승인약 1개(줄베특시맵)와 3상 단계의 ADC 2개(IBI343, AZD0901)가 앞서 있고, 그중 IBI343은 LMB-201과 같은 TOPO1 억제 페이로드 계열입니다. 기술이전 협상에서는 임상 데이터 이전에 “선행 자산과 무엇이 다른가”에 대한 답변이 요구될 것입니다.

규제·특허 측면에서는 독점 기간보다 링커·페이로드 원천 특허에 대한 자유실시(FTO) 확인과 제조(CMC) 준비가 우선 과제입니다. 미국에서는 물질특허 만료(2044년)보다 생물학적약품 독점 기간 만료(2049년)가 늦어 독점 기간 자체는 제약 요인이 아닙니다. 다음 쪽에 영역별 판정과 90일 이내 권고 사항을 정리하였습니다.

■ **영역별 판정** 각 영역은 사전에 정한 기준으로 판정하였으며, 여섯 영역을 합산한 종합 점수는 산정하지 않았습니다

임상은 양호, 재무는 미달, 시장·규제·특허는 주의로 판정됩니다.

영역	판정	판정 사유	주요 근거
임상	양호	CLDN18.2 선별 환자 대상 설계로 성공확률 상향 요인이 있습니다. ADC 기준 누적 승인확률 10.8%는 고탄암 전체 기준(4.6%)과 구분하여 제시하였으며, 3상 이후 단계는 표본이 적다는 점을 함께 밝힙니다.	BIO 2021 · Wong 2019
재무	미달	IND 제출(8개월 후)까지 자금 총족 비율은 1.98입니다. P1 완료(41.4개월 후)까지는 0.38이며, 현 소진을 기준 최소 79억 원이 부족합니다. 조달 착수 마감 시점은 2027년 7월입니다.	귀사 재무 자료 · BIO 2021 단계 기간
시장	주의	위암은 연간 신규 환자 2.9만 명(2022년)의 큰 시장이나, 같은 표적의 승인약 1개와 3상 ADC 2개가 앞서 있어 진입 순서는 네 번째 이후로 추정됩니다.	국가암등록통계 · FDA · ClinicalTrials.gov
규제	주의	ADC는 제조 공정 자체가 제품 규격을 결정하므로 CMC 준비가 허가 위험 요인입니다. 반응물 기반 가속승인은 후보로 검토할 수 있습니다. 희귀의약품 지정은 위암은 해당하지 않으며, 체장암은 추가 확인이 필요합니다.	FDA-식약처 제도 · 42 U.S.C. § 262
특허	주의	출시 예상 시점(2037년)에 물질특허 잔여 기간은 7년입니다. TOP1 계열 페이로드와 링커에 원천 특허 보유자가 있어 FTO 확인이 필요합니다. 표적의 타당성은 동일 표적 약물의 허가로 입증되어 있습니다.	공개 특허 · 기업 공시 조사
경쟁 동향	정식판 제공	경쟁 3상 IBI343(G-HOPE-001)의 1차 완료 예정일은 2026년 12월입니다. 결과가 공개되면 시장 ·임상 판정을 다시 산정해야 합니다.	ClinicalTrials.gov

90일 이내 권고 사항 판정을 낮춘 요인 순서

1. 페이로드-링커 FTO 조사 엑사테칸 계열 페이로드와 절단형 펩타이드 링커를 Daiichi Sankyo(DXd) 등 원천 특허 보유자의 청구항과 비교한 회피 근거를 IND 제출 전에 문서로 확보할 것을 권고합니다. 라이선스가 필요하다면 그 비용을 필요 자금을 반영해야 합니다. 상세 11쪽	2. 시리즈A 착수 일정 확정 현금 소진 예상 시점은 2028년 1월, 조달 착수 마감은 2027년 7월입니다. 목표 시점(2027년 4월)이 3개월 이상 지연되면 IND 직후 자금 공백이 발생합니다. 두 번째 조달 계획을 시리즈A 자료에 함께 제시하는 것이 바람직합니다. 상세 6~7쪽	3. 체장암 코호트 결정 근거 확보 국내 체장암 최신 진료인원(현재 확인된 자료는 2020년 20,818명)과 미국 유병 인구를 확인한 뒤, 설계안 B(체장암 확장 코호트 추가)의 채택 여부를 결정할 것을 권고합니다. 상세 9-12쪽
--	---	---

본 보고서가 답하는 질문

현재 자금으로 어디까지 가는가	IND 제출까지는 도달합니다. P1 완료까지는 두 차례 추가 조달이 필요합니다. — 6~7쪽
이 설계의 성공확률은 얼마인가	ADC 기준 P1 진입 후 승인까지 10.8%, 고탄암 전체 기준 4.6%입니다. — 4~5쪽
어느 적응증부터 진입하는가	위암은 진입 순서 네 번째 이후, 체장암은 두 번째 이후이며 희귀질환 기준의 경계에 있습니다. — 8~9쪽
어느 경로로, 몇 년의 독점권인가	한국 신약·미국 BLA 경로이며 미국 실효 독점 종료는 2049년입니다. — 10쪽
타사 특허가 걸림돌이 되는가	항체는 자체 개발이나 링커-페이로드에 확인이 필요한 특허군이 있습니다. — 11쪽
같은 물질로 무엇을 바꿀 수 있는가	설계안 B는 비용 1.5배·기간 6개월 증가 대신 두 번째 적응증과 신속 제도 선례를 확보합니다. — 12쪽

■ 분석 대상과 전제

귀사가 제공한 12개 항목을 바탕으로 분석 기준을 다음과 같이 설정하였습니다.

본 보고서의 수치는 귀사가 제공한 자료와 공개 문헌·통계를 결합하여 산출하였습니다. 성공확률, 기간, 비용과 같은 업계 기준값은 약물 분류·적응증·개발 단계가 일치하는 자료를 우선 적용하였고, 일치하는 자료가 없는 경우에는 조건을 한 단계씩 넓혀 적용한 뒤 그 사실을 본문에 밝혔습니다. 입력값이 변경되면 동일한 기준으로 다시 산정할 수 있습니다.

귀사 제공 자료 ○ 가상 입력값

항목	내용
회사	(주)루미어스바이오 · 비상장 · 2022년 설립 · 임직원 14명
자산	LMB-201 · 항-CLDN18.2 ADC · TOP01 억제 페이로드(엑사테칸 유도체) · 절단형 펩타이드 링커 · 부위 특이적 결합 · DAR 4
적응증	CLDN18.2 양성(IHC 2+ 이상, 중앙세포 40% 이상) 위암 · 위식도접합부 선암, 2차 이상
현재 단계	비임상 · GLP 독성시험 진행 중 · IND 제출 목표 2027년 5월(식약처)
사업화 목표	P1 완료 후 기술이전
설계안 A	용량증량 + 확장, 36명, 국내 4개 기관, 24개월, 공개·단일군, 1차 평가변수 DLT-RP2D, 2차 평가변수 ORR
설계안 B	설계안 A + 웨장암 확장 코호트, 54명, 한국·미국 7개 기관, 30개월
재무	현금·단기금융상품 58억 원 · 정부과제 전용 9억 원 · 월 소진 3.1억 원 (최근 6개월 영업현금유출 평균) · 확정 조달 없음
자본 구조	프리A 상환전환우선주(RCPS) 58억 원, 2024년 11월
조달 계획	시리즈A 150억 원, 2027년 4월 목표
특허	물질특허 PCT 2024년 3월 출원(심사 중), 만료 예상 2044년 · 특허청 출원 4건
후속 자산	LMB-305(탐색 단계)

분석 기준

약물 분류	항체-약물 접합체(ADC) 특허 분류상 ADC와 단클론항체 성격이 함께 나타나며, 귀사 확인에 따라 ADC로 분류
적응증 분류	항암 · 고형암(위암)
개발 단계	비임상 · 다음 단계 P1
희귀질환	해당 없음 (1차 적응증 기준)
검토 지역	한국 · 미국
자본 구조	전환증권 보유 기업 RCPS 조건에 따른 희석·상환 영향은 정식판에서 산정
1차 목표 시점	IND 제출 · 비임상 자산의 다음 가치 상승 시점
2차 목표 시점	P1 완료 · 귀사의 기술이전 목표 시점
상장 여부	비상장 · 공시 재무 자료 없음, 제공 자료 사용

판정과 표기

양호	사전 기준상 긍정 요인
주의	추가 확인·대응이 필요한 요인
미달	자금 총족 비율 1.0 미만 등 기준 미달
정식판 제공	정식판 보고서에서 제공되는 항목
● ○ ◇	● 공개 문헌·통계 ○ 귀사 제공 자료(가상) ◇ 예시 수치(본 예시 보고서용)

제공 자료에서 확인한 전제 세 가지

월 소진액은 6개월 평균값입니다. 최근 6개월 영업현금유출 평균 3.1억 원을 적용하였습니다. 임상 착수 후에는 CRO 비용과 제조비가 더해져 소진액이 증가하므로, 본 수치는 비임상 단계의 소진 수준으로 이해하여야 합니다.

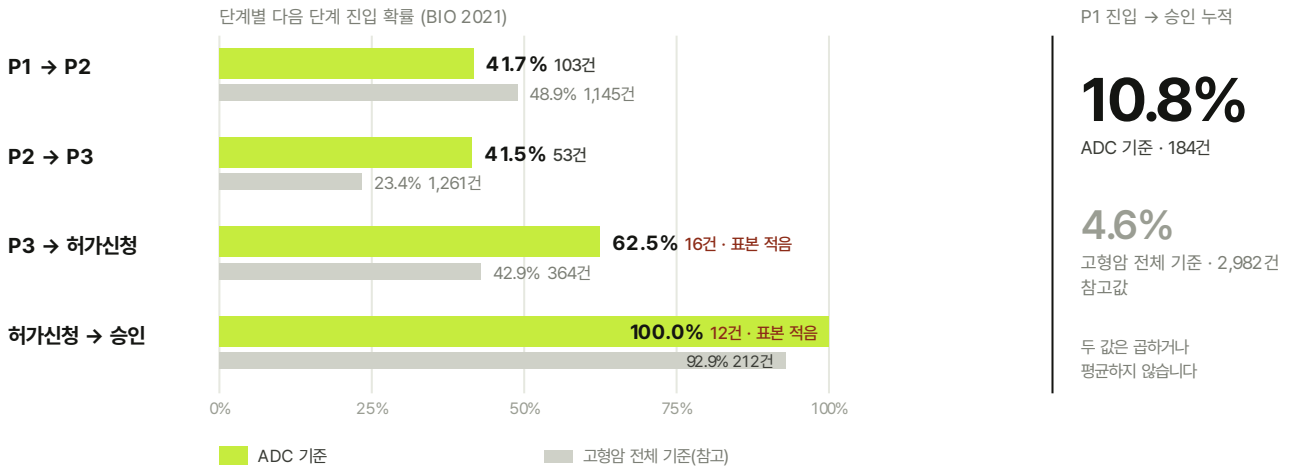
정부과제 전용 현금 9억 원은 런웨이에서 제외하였습니다. 과제비는 사용 용도가 정해져 있어 임상 준비 이외의 지출에 사용할 수 없기 때문입니다. 과제 매칭 의무 현금이 있다면 필요 자금에 가산해야 하며, 이 부분은 정식판에서 산정합니다.

프리A가 RCPS로 발행되어 전환증권 보유 기업으로

분류하였습니다. 전환가, 리픽싱, 상환 조건에 따라 시리즈A에서의 지분 희석과 상환 부담이 달라집니다. 본 예시본에서는 해당 수치를 산정하지 않았습니다.

■ 임상 이 약물 분류·적응증·단계의 성공확률은 얼마인가

ADC 기준 P1 진입 후 승인까지 누적 10.8%입니다. 고형암 전체 기준 4.6%와 구분하여 제시합니다.



수치의 해석

2011년부터 2020년까지 FDA 허가를 목표로 P1에 진입한 ADC 개발 프로그램 가운데 약 11%가 승인에 이르렀다는 의미입니다. 여기에서 개발 중단에는 과학적 실패뿐 아니라 상업성이나 포트폴리오 판단에 따른 중단이 포함되며, 임상 평가변수 달성률과는 다른 개념입니다. 따라서 본 수치는 “LMB-201이 승인될 확률”이 아니라 “같은 조건의 프로그램이 승인에 이른 비율”로 이해하셔야 합니다.

고형암 전체 기준 4.6%와 두 배 이상 차이가 나는 것은 두 수치의 모집단이 다르기 때문입니다. ADC 수치는 질환을 구분하지 않은 약물 분류 기준이고, 고형암 수치는 약물 분류를 구분하지 않은 질환 기준입니다. 두 값을 곱하거나 평균하여 ‘ADC·고형암’ 수치를 만드는 것은 서로 다른 모집단의 확률을 혼합하는 것이므로, 본 보고서는 두 값을 나란히 제시합니다.

현재 비임상 단계이므로 위 수치는 P1 진입 이후부터 적용됩니다. 비임상에서 P1으로 진입할 확률은 본 예시본에서 산정하지 않았으며, 정식판에서는 비임상 단계 이탈률 문헌을 반영하여 함께 제공할 예정입니다.

적용 기준의 선정

순서	검토한 기준	적용
1	ADC이면서 항암인 프로그램	공개 자료 없음
2	ADC 전체 · BIO 2021, 184건	기본값 채택
3	고형암 전체 · BIO 2021, 2,982건	참고값 병기
참고	항암 전체 3.4% · Wong 2019(2000~2015년, 개발 경로 기준). 산출 방식과 기간이 달라 참고로만 제시	상세 참고

표본 크기 확인

표본 적용 ADC의 3상→허가신청(16건), 허가신청→승인(12건) 단계는 표본이 적용됩니다. P1 누적 10.8%는 이 두 단계를 포함하므로 기본값으로 제시하되, 후반 단계의 불확실성이 크다는 점을 함께 밝힙니다.

투자자·평가위원회에게는 “ADC 기준 10.8% (184건), 고형암 기준 4.6%(2,982건), BIO 2021”과 같이 조건과 표본 수를 함께 제시할 것을 권고합니다. 한 수치만 제시하면 적용 조건에 대한 질의가 뒤따를 가능성이 높습니다.

■ 임상 이 설계에서 심사 과정의 지적 사항이 예상되는가

설계안 A는 환자 선별 설계가 강점이며, 단일군·반응률 구조는 다음 단계에서 보완 설명이 필요합니다.

설계안 A 검토 결과

판정 검토 항목과 의견

양호	바이오마커 선별 집단 — 바이오마커로 선별한 집단은 반응률과 성공확률이 높게 보고됩니다(Wong 2019). 선별 진단법의 동반 개발 계획을 함께 준비해야 합니다.
중립	항암 1상 환자 대상 — 항암 1상은 환자를 대상으로 하는 것이 일반적이며, 용량 확장 코호트에서 초기 효능 신호를 함께 확인합니다.
해당 없음	대상자 수 — 계획 인원 36명은 같은 적응증·단계 시험 ◇ 184건의 중앙값(하위 25% 20명 · 중앙 36명 · 상위 25% 66명)과 같아 검정력 문제는 지적되지 않습니다. 미국 항암 P1 시험의 평균 대상자 수는 58명입니다(ASPE 2024).

개발 기간 항암 평균, BIO 2021

구간	P1→P2	P2→P3	P3→신청	신청→승인	합계
평균(년)	2.7	3.7	3.1	0.8	10.3

ADC 전용 기간 자료가 없어 항암 평균을 적용하였습니다. 개별 시험 1건 기준의 P1 기간(중앙값 1.6년, Wong 2019)은 정의가 달라 합산하지 않았습니다.

설계안 A에 대한 의견

선별 기준은 본 설계의 가장 큰 강점입니다. 승인약 줄베특시맙은 중앙세포 75% 이상에서 중등도 이상 염색을 양성으로 정의하였고, 동반진단(VENTANA CLDN18 43-14A)과 함께 승인되었습니다. 설계안 A는 IHC 2+ 이상 ·40% 이상이라는 보다 넓은 기준을 적용합니다. 넓은 기준은 모집에 유리하나, 발현이 낮은 환자에서 반응이 떨어질 경우 확장 코호트 결과의 해석이 어려워집니다. 발현 수준별 반응을 구분하여 볼 수 있도록 층화 계획을 설계서에 명시할 것을 권고합니다.

단일군·공개 설계와 ORR 평가는 1상에서 통상적인 구성입니다. 다만 귀사의 사업화 목표가 P1 완료 후 기술이전이므로, 상대 기업이 주목할 자료는 안전성보다 확장 코호트의 반응률과 반응 지속 기간입니다. 12명 규모의 확장 코호트는 반응률의 신뢰구간이 넓습니다. 반응률을 협상 근거로 활용하려면 확장 규모를 늘리거나, 12명 결과로 협상을 개시하고 확장을 이어 가는 두 단계 계획을 미리 수립하는 것이 바람직합니다.

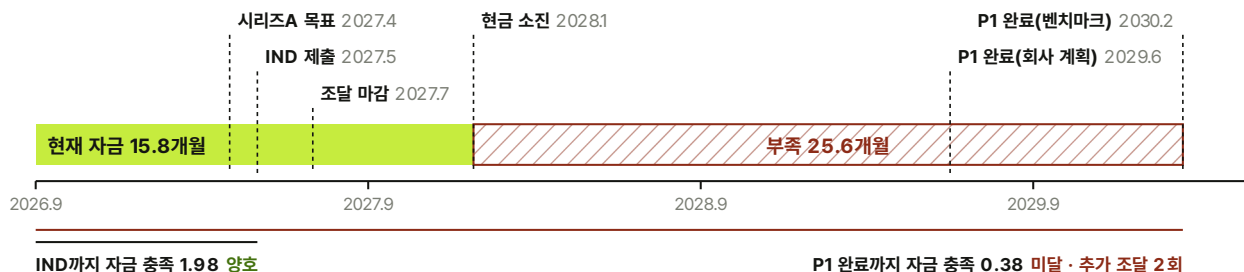
개발 기간은 “P1 완료까지 2.7년”을 기준으로 보셔야 합니다. 10.3년은 승인까지의 평균이며, 본 보고서의 재무 분석은 P1→P2 전환 기간 2.7년을 적용하였습니다. 이는 귀사 계획(24개월)보다 8개월 길지만, 계획대로 24개월에 완료되더라도 재무 판정은 달라지지 않습니다.

설계서에 명시할 것을 권고하는 항목 심사와 기술이전 협상에서 반복적으로 제기되는 질문

항목	기재할 내용	관련 판정
발현 수준별 층화 계획	확장 코호트에서 IHC 2+와 3+, 40~74%와 75% 이상을 구분하여 집계하는 사전 계획과 층별 최소 인원	양호 선별 설계
동반진단 계획	선별에 사용하는 IHC 항체·판독 기준, 승인 동반진단과의 일치도 확인 계획	양호 선별 설계
확장 코호트 규모의 근거	12명으로 얻을 수 있는 반응률 신뢰구간과, 협상 근거로 활용할 경우의 추가 모집 조건	중립 항암 1상
줄베특시맙 투여 경험 환자	포함 여부와 근거, 포함 시 하위군 별도 집계 계획	시장 8쪽
P1 제조 배치와 상업 공정의 차이	P1 배치 제조처·규모, 향후 공정 변경 예정 항목과 비교동등성 계획	주의 규제 10쪽

■ 재무 현재 자금으로 목표 시점까지 도달하는가

가용 현금 49억 원으로 15.8개월을 운영할 수 있습니다. P1 완료까지는 25.6개월이 부족합니다.



자금 도달성에 대한 의견

IND 제출까지는 자금 문제가 없습니다. 현재 소진율을 유지할 경우 8개월 후 IND 제출 시점에 약 24억 원이 남습니다. 자금 총족 비율 1.98은 추가 조달 없이 목표 시점에 도달할 수 있는 범위입니다. 다만 비임상에서 IND까지의 업계 평균 기간 자료가 없어 귀사 계획(8개월)을 그대로 적용하였습니다. GLP 독성시험 보고서 지연 등으로 IND 제출이 4개월 늦어지더라도 비율은 1.3으로 주의 범위에 머물렀습니다.

P1 완료까지는 두 차례의 조달이 필요합니다. 항암 P1→P2 평균 기간 2.7년을 적용하면 현재부터 41.4개월이 소요되며, 현재 자금은 그중 15.8개월을 감당합니다. 필요 조달 횟수는 $41.4 \div 15.8$ 을 올림한 값에서 1을 뺀 2회입니다. 귀사 계획 기간(24개월)을 적용하더라도 비율은 0.48로 미달이며, 필요 횟수 또한 같습니다. 이 결론은 기간 가정에 크게 좌우되지 않습니다.

조달 착수 마감은 2027년 7월입니다. 국내 초기 투자 라운드는 착수부터 입금까지 통상 6개월이 소요된다는 가정을 적용하였습니다. 시리즈A 목표 시점(2027년 4월)은 마감보다 3개월 앞서 있어 현재로서는 일정 충돌이 없습니다. 그러나 목표가 3개월 이상 지연되면 IND 제출 직후 잔여 운영 기간이 6개월 미만으로 줄어듭니다.

자금 도달성 산정

항목	값
런웨이 = $(58 - 9) \div 3.1$	15.8개월
현금 소진 예상 시점	2028년 1월
조달 착수 마감 = 소진 시점 - 6개월	2027년 7월
IND까지 자금 총족 = $15.8 \div 8.0$	1.98 양호
P1 완료까지 = $15.8 \div (8 + 1 + 32.4)$	0.38 미달
필요 추가 조달 횟수	2회

자금 총족 비율 = 런웨이 ÷ 목표 시점까지 필요 기간. 1.5 이상 양호, 1.0~1.5 주의, 1.0 미만 미달로 판정합니다. P1 구간은 항암 P1→P2 평균 2.7년(BIO 2021)에 IND 심사 1개월을 더하였으며, 모집 지연 가능성은 반영하지 않았습니다.

후속 자산

중립 LMB-201 개발이 중단될 경우 LMB-305(탐색 단계)와 잔여 현금이 남습니다. 후속 자산의 가치 산정은 정식판에서 제공합니다.

시리즈A 자료에는 “IND까지 자체 자금, P1 완료까지 2회 조달”이라는 구조를 먼저 제시하고, 두 번째 조달 시점을 확장 코호트의 첫 반응 데이터 확보 직후로 설정한 계획을 함께 제시할 것을 권고합니다.

■ 재무 P1까지 필요한 자금과 비교 기업의 같은 단계 재무

설계안 기준 임상 직접비 3.72M\$는 업계 평균의 15% 수준입니다. 제외된 네 가지 비용 항목을 반영하면 격차가 줄어듭니다.

필요 자금 산정 방식이 다른 값은 합산하지 않고 병기

구분	값 기준
비임상 단계 비용(업계 모델)	5.0M\$ Paul 2010, 기준연도 미기재
P1 단계 비용(업계 평균)	25.3M\$ DiMasi 2016, 2013년 달러, 대형사·실패 포함, 중앙값 17.3M\$
P1 약물당 직접비	7.1M\$ ASPE 2024, 2018년 달러, 미국
설계안 A 최소 = 36명 × 103,344\$	3.72M\$ ASPE 2024, 미국 항암 P1 환자당 비용

비용 편차 주의 설계안 기준 최소값이 업계 평균보다 85% 낮습니다. 설계안 값에는 기관 개설비, CRO 월 비용, 국내 환자당 단가, ADC 제조(CMC) 비용이 포함되지 않았습니다.

자금 부족분

IND 시점 잔여 현금	약 24억 원 = $49 - 3.1 \times 8$
P1 완료까지 최소 부족분	79.3억 원 = $3.1 \times 41.4 - 49 \cdot$ 운영비 기준
별도 소요	임상 직접비 최소 3.72M\$(달러 기준)

비교 기업의 같은 단계 재무 ◇ 예시 수치

국내 상장사 5곳, 비임상→IND 시점	하위 25%	중앙	상위 25%	귀사
런웨이(개월)	13	21	34	15.8
월 소진(억 원)	5.8	8.9	14.2	3.1

국내 상장 신약개발사 가운데 ADC·항암 자산을 보유하고 같은 단계를 거친 기업을 선정하여, 해당 시점의 공시 재무를 비교하였습니다. 평균 대신 분위값만 제시합니다.

필요 자금에 대한 의견

산정 방식이 다른 두 값은 합산하지 않고 병기하였습니다.

업계 평균 25.3M\$는 대형 제약사 규모에 실패한 프로그램의 지출까지 포함한 값이며, 설계안 최소 3.72M\$는 대상자 수에 환자당 단가만을 곱한 값입니다. 정의가 다르므로 어느 한쪽이 잘못된 것이 아니며, 귀사가 실제 집행할 예산은 두 값 사이에 위치할 것으로 판단됩니다. 가장 근접한 참고값은 미국 항암 P1의 약물당 직접비 7.1M\$입니다.

설계안 기준 금액이 낮게 산출된 것은 제외된 비용 항목 때문입니다. 특히 ADC는 항체-링커-페이로드-접합의 세 공정에 대한 GMP 생산이 필요하여, 제조비가 임상비에 준하는 규모가 되는 경우가 있습니다. CDMO 견적을 확보하여 네 항목을 반영하면 설계안 기준 금액은 7~10M\$ 범위로 상향될 가능성이 높습니다.

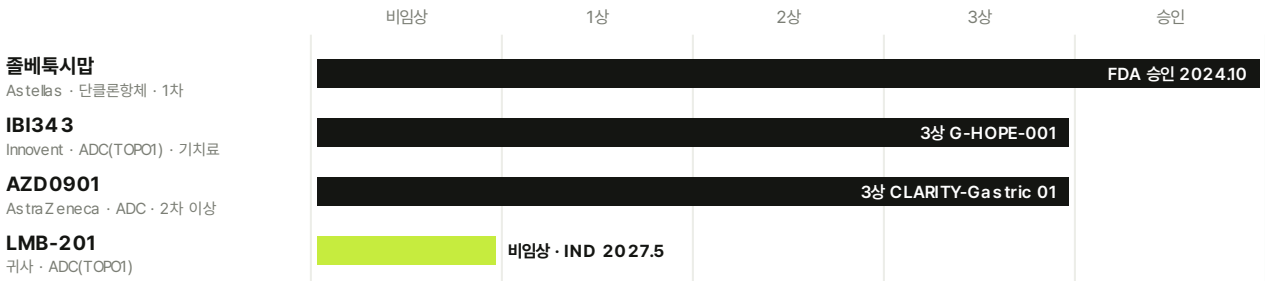
원화 부족분 79.3억 원은 운영비만을 기준으로 한 최소값입니다. 현재 소진율이 P1 기간 동안 유지된다는 가정이며, 임상 직접비는 달러 기준으로 별도 표기하였습니다. 시리즈A 150억 원이 유입되면 운영비 부족분은 해소되지만, 임상 직접비와 제조비를 더하면 P1 후반에 두 번째 조달이 필요하다는 결론은 유지됩니다.

비교 기업 대비 낮은 소진액은 장점이자 유의 사항입니다. 귀사의 월 소진액 3.1억 원은 비교 기업 하위 25%(5.8억 원)보다 낮아 런웨이가 길게 산출됩니다. 그러나 임상 착수 후 소진액은 통상 두 배 이상 증가하므로, 시리즈A 이후 런웨이는 월 6~9억 원 수준을 가정하여 재산정할 것을 권고합니다.

■ 시장 어떤 경쟁 자산이 앞서 있는가

위암에서는 같은 표적의 선행 자산이 3개이며, 그중 하나는 LMB-201과 같은 페이로드 계열입니다.

위암 CLDN18.2 선행 자산과 진입 순서 확인된 자산 기준의 최소값



진입 순서 추정 = 1 + 귀사보다 개발 단계가 앞선 동일 표적 자산 수 = 네 번째 이후, ● FDA(2024.10.18), ClinicalTrials.gov(NCT06238843), CLARITY-Gastric 01 시험 개요

경쟁 구조는 두 층으로 구성되어 있습니다. 1차 치료에는 줄베특시맵이 항체 형태로 이미 사용되고 있으며, 2차 이상에서는 ADC 두 개(IBI343, AZD0901)가 3상을 진행하고 있습니다. LMB-201이 목표로 하는 2차 이상 위암은 두 ADC와 직접 겹칩니다. LMB-201이 P1을 마칠 2030년 전후에는 두 ADC 중 하나 이상이 결과를 발표하였거나 허가 절차에 있을 가능성이 높습니다.

IBI343과 같은 페이로드 계열이라는 점이 협상의 핵심 쟁점입니다. IBI343은 TOPO1 억제 페이로드 ADC이며, LMB-201 역시 액사테칸 유도체 TOPO1 페이로드를 사용합니다. 기술이전 상대 기업은 “IBI343 대비 무엇이 우수인가”를 우선 확인할 것입니다. 이에 대한 답변은 선별 기준, 링커-접합 방식에 따른 안전성, 치료 차수 설정의 세 방향에서 준비할 수 있으며, 아래 표에 정리하였습니다.

진입 순서가 늦다는 것이 시장 진입 불가를 의미하지는 않습니다. 같은 표적에서 후발 ADC가 선발 항체보다 큰 시장을 확보한 사례(HER2 표적 ADC)가 있습니다. 다만 그 경우에도 명확한 효능 차이가 전제였습니다. 비임상 단계에서 후발 진입의 근거를 마련하지 못하면, 사업화 경로가 기술이전보다 공동개발이나 아시아 지역 권리 계약으로 좁혀질 수 있습니다.

줄베특시맵 투여 경험 환자의 포함 여부를 조기에 결정해야 합니다. 1차에서 CLDN18.2 항체를 투여받고 진행한 환자는 2차에서 CLDN18.2 ADC의 대상이 됩니다. 이 환자군에서 표적 발현이 유지되는지에 대한 근거는 아직 제한적이므로, 포함하면 학술적 차별점이 생기고 제외하면 모집이 단순해집니다.

협상 전에 답해야 할 세 가지 질문 비임상 단계에서 준비할 근거와 P1에서 확인할 자료

질문	비임상 단계에서 준비할 근거	P1 확장 코호트에서 확인할 자료
선별 기준이 달라 대상 환자가 넓은가	발현 수준별(IHC 1+·2+·3+) 세포주·PDX 반응 자료, 귀사 기준(2+·40% 이상)과 승인약 기준(75% 이상)의 해당 환자 비율 비교	발현 수준별 반응률·반응 지속 기간
링커-접합 방식이 달라 안전성이 우수한가	DAR 균일성, 혈중 유리 페이로드 농도, 동종 페이로드 ADC 대비 GLP 독성 비교(간질성 폐질환·혈액 독성 지표)	용량 제한 독성의 종류와 발생 용량, 권장 용량에서의 유리 페이로드 노출
치료 차수를 달리 설정할 수 있는가	줄베특시맵 투여 후 진행 검체의 CLDN18.2 발현 유지 근거(문헌·협력 병원 조직)	줄베특시맵 투여 경험 하위군의 반응을

■ 시장 어느 적응증부터 진입하는가, 유사 조건의 기술이전 규모는 어떠한가

위암은 환자 규모가 크고 췌장암은 경쟁이 적습니다. 췌장암은 국내 희귀질환 기준의 경계에 있습니다.

적응증 비교

항목	위암-위식도접합부 (설계안 A)	췌장암 (설계안 B 추가)
국내 환자 규모	2022년 신규 발생 29,487명 , 유병자 356,507명(2023.11 기준) ● 보건복지부-중앙암등록본부, 국가암등록통계 2022	2020년 건강보험 진료인원 20,818명 (2016년 16,086명, 연평균 6.7% 증가) ● 국민건강보험공단 발표(언론 보도 인용)
CLDN18.2 양성 비율	38.4% (종양세포 75% 이상 중등도 이상 염색 기준) ● Shitara 외, Gastric Cancer 2024	50~70% ● Innovent 보도자료(2024.6)의 문헌 인용
승인된 동일 표적 약	줄베특시맙 1차 병용(HER2 음성), FDA 2024.10	없음
3상 CLDN18.2 ADC	IBI343(기치료, G-HOPE-001) · AZD0901(2차 이상)	IBI343(3차 이상, 위약 대조)
진입 순서 추정	네 번째 이후 주의	두 번째 이후
국내 희귀질환 규모 기준	해당 없음 — 연간 신규 발생만으로 2만 명 초과	경계 — 2020년 기준 2만 명 초과, 최신 자료 확인 필요
급여 등재 경로	항암 신약: 약제급여평가위원회(급여 적정성) → 건강보험공단 협상(약가) → 건강보험정책심의위원회 의결. 경제성평가 면제 트랙과 위험분담제 적용 여부가 등재 기간과 약가 수준을 좌우합니다.	협상(약가) → 건강보험정책심의위원회 의결. 경제성평가 면제 트랙과 위험분담제 적용 여부가 등재 기간과 약가 수준을 좌우합니다.

적응증 선택에 대한 의견

환자 수와 양성 비율은 곱하지 않았습니다. 위암 29,487명은 병기를 구분하지 않은 연간 신규 발생 수이고, 38.4%는 진행성·전이성 환자를 대상으로 한 3상 선별 검사의 결과입니다. 두 값의 대상 집단이 달라 곱하면 2차 이상 진행성 환자 수가 과대 추정됩니다. 치료 차수별 환자 수는 정식판에서 역학 자료를 반영하여 제공합니다.

췌장암을 검토할 이유는 환자 수보다 경쟁 구조와 제도에 있습니다. 국내 진료인원은 위암 신규 발생의 약 70% 수준이지만, CLDN18.2 양성 비율이 높고, 3상 단계의 선행 ADC가 하나이며, 그 자산이 FDA 패스트트랙(Fast Track)을 받아 제도 선례가 있습니다. 반면 국내 희귀의약품 지정은 2020년 진료인원이 이미 2만 명을 넘어 규모 기준 충족이 어렵고, 질병관리청 지정 희귀질환이 아니어서 기존 치료제 대비 개선 입증도 요구됩니다. 따라서 췌장암을 두 번째 적응증으로 검토한다면, 그 근거는 국내 희귀의약품 혜택이 아니라 미국 개발 경로 확보에 두어야 합니다.

유사 조건의 기술이전 ADC, 비임상~P1 · 국내 공시

거래	계약금
리가캠바이오 → J&J(얀센), 2023.12 LCB84, TROP2 ADC, 비임상~P1	1,304억 원
리가캠바이오 → 오노약품, 2024.10 LCB97, L1CAM ADC, 비임상	비공개

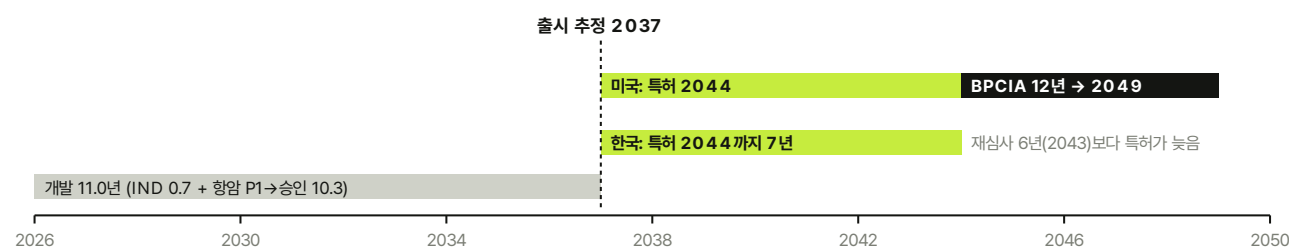
조건에 해당하는 사례가 5건 미만이었어서 분위값 없이 사례만 제시하였습니다.
리가캠바이오 사례는 “비임상 ADC도 천억 원대 계약금이 가능하다”보다 “검증된 링커-페이로드 플랫폼과 비교 자료가 있을 때 가능하다”로 해석하는 것이 적절합니다. LCB84는 자체 플랫폼(ConjuAll) 기반 자산이었으며, 상대 기업은 플랫폼 검증 자료를 함께 평가하였습니다. LMB-201이 같은 범주로 평가받으려면 귀사의 접합 기술이 플랫폼으로 검증되었음을 보여 주는 자료가 필요합니다.

자산 가치 정식판 제공

예상 최대 매출, 위험조정 순현재가치(rNPV), 시장 규모 등급은 정식판에서 약가·치료율·점유율 자료를 반영하여 제공합니다. 사업화 시점은 귀사가 제시한 P1 완료 후 기술이전을 기준으로 분석하였습니다.

■ 규제 어느 경로로, 몇 년의 독점권을 확보하는가

미국에서는 특허(2044년)보다 생물의약품 독점(2049년)이 늦게 만료됩니다. 허가 위험은 제조(CMC)에 있습니다.



출시 예상 시점 = 2026년 + 개발 기간 11.0년(IND까지 0.7년 + 허가 P1→승인 평균 10.3년, BIO 2021). 한국 신약 재심사(자료보호) 6년, 미국 생물의약품 독점 12년(42 U.S.C. § 262(k)(7)) ●. 실패 독점 종료 시점은 특허 만료와 허가 후 독점 만료 중 늦은 시점입니다. 특허 존속기간 연장(최대 5년)은 정식판에서 반영합니다.

규제 검토 결과

판정 검토 항목과 의견

중립	허가 경로 — 한국 신약(생물의약품, 전체 자료 제출), 미국 BLA 351(a). 자료 일부 생략 경로에는 해당하지 않습니다.
주의	제조(CMC) — ADC는 공정이 제품 규격을 결정합니다. DAR 분포와 유리 페이로드 규격, 항체-링커-페이로드 각각의 GMP 공급처, 공정 변경 시 비교동등성 자료를 준비해야 합니다.
양호	신속 허가 제도 — 항암제로서 반응률(ORR) 기반 자료를 확보하면 FDA 가속승인과 식약처 조건부 허가의 대상이 될 수 있습니다. 확증시험 실패 시 허가 철회 위험이 함께 따릅니다.
중립	선례 — 동일 표적 ADC인 IBI343이 확장암으로 FDA 패스트트랙을 받았습니다(2024.6) ●. 패스트트랙은 단독으로는 개발 기간 단축 효과가 크지 않은 소통·순차 제출 제도입니다.
주의	희귀의약품 지정 — 위암은 해당하지 않습니다. 확장암은 국내 규모 기준(2만 명 이하)의 경계이며, 질병관리청 지정 희귀질환이 아니어서 2026년 개정 규정에서도 기존 치료제 대비 개선 입증에 필요합니다. 미국 지정 가능성은 정식판에서 미국 유병 자료를 반영하여 판단합니다.

규제 측면 의견

독점 기간은 미국과 한국에서 다르게 결정됩니다. 미국은 생물의약품 허가 후 12년간 바이오시밀러 허가 제한되므로, 2037년 출시를 가정하면 특허와 무관하게 2049년까지 독점이 유지됩니다. 한국은 재심사 기간 6년이 특허 만료(2044년)보다 먼저 끝나므로 특허가 실패 독점 기간을 결정합니다. 따라서 미국 시장 가치를 특허 잔여 7년 기준으로 산정하면 과소평가가 됩니다.

제조를 주의 요인으로 판정한 것은 ADC 허가 지연의 상당 부분이 제조에서 발생하기 때문입니다. 항체, 링커-페이로드, 접합의 세 공정 각각에 GMP 자료가 필요하고, P1 이후 공정을 변경하면 비교동등성 자료가 추가됩니다. 줄베특시맵 역시 임상 자료가 아니라 위탁 제조시설 문제로 한 차례 보완 요구를 받은 바 있습니다. IND 이전에 P1용 배치의 제조처와 규모, 상업 공정과의 차이를 확정할 것을 권고합니다.

가속승인은 검토 대상일 뿐 계획의 전제로 삼지 않는 것이 바람직합니다. 반응률 기반 가속승인은 출시를 앞당기는 대신 확증시험 실패 시 철회 위험을 수반합니다. 출시 시점 단축과 철회 위험을 함께 반영한 가치 산정은 정식판에서 제공합니다.

■ 기술·특허 타사 특허가 걸림돌이 되는가, 귀사 특허는 몇 년 남는가

항체는 자체 개발이더라도 링커와 페이로드에는 원천 특허 보유자가 있습니다.

특허 검토 결과

판정 검토 항목과 의견

중립	출시 시점 잔여 특허 기간 7년 — 2044년 - 2037년. 5년 이상으로 특점 기간 부족 문제는 없습니다. 만료 연도는 등록 전 예상값입니다.
주의	자유실시(FTO) — 항체가 자체 개발이더라도 링커·접합·페이로드 화학에는 타사 특허가 남습니다. TOP01 계열에서는 Daiichi Sankyo(데루스테인/DXd), Tubulis/Gilead(Tubutecan) 등이 원천 특허를 보유하고 있습니다. 세 구성 요소의 로열티가 중첩되면 수익성이 낮아집니다.
양호	표적의 근거 수준 — 동일 표적 약물(줄베특시맵)이 3상에서 생존 이익을 입증하고 허가를 받았으므로, 표적 타당성은 가장 높은 수준의 근거(사람에서의 인과성)를 갖습니다.

특허 포트폴리오 특허청 출원 4건 ○ 가상 자료

출원	IPC	만료
항-CLDN18.2 항체 및 용도 물질특허 KR 2023.3 · PCT 2024.3 · 심사 중 · 항체의약의 원천 기술 분류	C07K16/28	등록 후 산정
항체-약물 접합체 조성물 PCT 2024.3 · 심사 중 · 항암 ADC 기술 분류	A61K47/68	등록 후 산정
캄토테신 유도체 링커-페이로드 KR 2025.2 · 심사 중 · 복소환 화합물 분류	C07D491/22	등록 후 산정
CLDN18.2 면역조직화학 검출 방법 KR 2025.6 · 심사 중 · 암 진단·동반진단 분류	G01N33/574	등록 후 산정

특허의 권리 범위와 강도는 청구항 분석이 필요한 사항으로, 본 보고서에서는 점수화하지
않았습니다.

특허 측면 의견

FTO 주의 판정은 특허 침해를 의미하지 않으며, 확인이
필요한 특허군이 있다는 의미입니다. ADC는 항체·링커·
페이로드 세 구성 요소가 각각 별도의 특허층을 갖습니다.
엑사테칸 유도체 페이로드와 절단형 펩타이드 링커의 조합은
Daiichi Sankyo의 DXd 계열 청구항과 구조적으로
가깝고, 부위 특이적 접합은 Synaffix 등 접합 화학 특허와
겹칠 수 있습니다. 페이로드, 링커, 접합 화학 순서로
확인하고, 청구항 비교표를 IND 이전에 작성해 둘 것을
권고합니다.

라이선스가 필요할 경우 비용은 구성 요소마다 발생합니다.
실무적으로 더 큰 위험은 소송보다 로열티 중첩입니다. 항체
특허를 보유하더라도 링커·페이로드에 각각 로열티를
지급하면, 기술이전 계약에서 귀사가 받을 수 있는 순
로열티가 줄어듭니다. 라이선스가 필요하다고 판단되면 그
비용을 필요 자금(7쪽)에 반영하고, 기술이전 시 상대 기업에
이전할 수 있는지를 사전에 검토해야 합니다.

포트폴리오는 구성이 적절하며 등록이 과제로 남아 있습니다.
물질(항체), 조성물(ADC), 페이로드, 진단 방법의 네 층으로
구성되어 있어 기술이전 상대 기업이 기대하는 형태를
갖추었습니다. 다만 4건 모두 심사 중이어서 만료 연도와
권리 범위가 확정되지 않았습니다. 물질특허의 심사 진행
상황과 주요국(미국·유럽·일본·중국) 국내 단계 진입 계획을
협상 자료에 포함할 것을 권고합니다.

표적에 대한 근거는 가장 높은 수준입니다. “CLDN18.2를
억제하면 위암이 개선되는가”라는 질문에는 이미 답이
있습니다. 남은 질문은 “ADC 형태가 항체보다
우수한가”이며, 이는 표적이 아니라 약물 형태에 대한 근거로
답해야 합니다.

■ 설계안 비교 같은 물질로 무엇을 달리할 수 있는가

설계안 B는 임상 직접비가 1.5배이고 기간이 6개월 늘어납니다. 대신 두 번째 적응증과 신속 허가 제도 선례를 확보합니다.

설계안 A · B 비교 동일한 기준으로 설계 조건만 변경하여 산정

항목	설계안 A · 위암 단독	설계안 B · 위암 + 췌장암
대상자 · 기관 · 기간	36명 · 국내 4곳 · 24개월	54명 · 한국·미국 7곳 · 30개월
임상 직접비 최소	3.72M\$	5.58M\$ (+50%)
P1 완료까지 자금 총족(귀사 계획 기준)	0.48 미달 · 33개월	0.41 미달 · 39개월
필요 추가 조달	2회	2회
3상 이상 동일 표적 선행 자산	3개	위암 3개 · 췌장암 1개
신속 허가 제도 선례	없음	췌장암 FDA 패스트트랙(IFI343)
희귀의약품 지정 가능성	한국·미국 해당 없음	한국 경계 · 미국 확인 필요
미국 임상 자료	없음	확보 — 기술이전 협상 시 미국 기관 자료 제시 가능
성공확률 기준값	동일(ADC 10.8%). 설계 요소별 성공확률 보정은 정식판에서 제공	

두 설계안의 차이는 추가 비용과 기간으로 무엇을 확보하는가의 문제입니다. 설계안 B는 대상자 18명과 6개월, 직접비 1.86M\$가 추가로 소요되며, 미국 기관 비용은 아직 반영되지 않았습니다. 확보하는 것은 세 가지입니다. 췌장암이라는 두 번째 적응증의 초기 반응 자료, FDA IND를 통과한 자산이라는 지위, 그리고 미국 기관에서 생성된 임상 자료입니다. 기술이전 상대가 미국·유럽 기업이라면 세 번째 항목의 가치가 큼니다.

설계안 B를 채택하더라도 설계안 A로 착수하는 순서를 권고합니다. 두 설계안 모두 자금 총족 비율이 미달이고 필요 조달 횟수도 같으며, 차이는 두 번째 조달의 규모입니다. 국내 IND로 용량증량을 먼저 진행하고 권장 용량(RP2D)이 정해진 뒤 미국 IND와 췌장암 확장 코호트를 추가하면, 미국 기관 비용이 발생하는 시점을 시리즈A 이후로 조정할 수 있습니다. 이 순서에서는 설계안 B의 추가 비용이 두 번째 조달의 근거 자료가 됩니다.

본 비교는 대상자 수와 기간만을 변경한 결과입니다. 정식판에서는 미국 기관 개설비·CRO 비용과 설계 요소별 성공확률 보정을 반영하여 두 설계안의 위험조정 가치 차이까지 산정합니다.

설계안 B 채택에는 두 가지 근거 확보가 선행되어야 합니다. 첫째, 미국 췌장암 유병 인구입니다. 20만 명 미만이면 미국 희귀의약품 지정(7년 독점, 수수료 면제) 가능성이 생기며, SEER 등 공식 통계로 확인할 수 있습니다. 둘째, 국내 췌장암 최신 진료인원입니다. 2020년 20,818명으로 이미 기준을 넘었고 증가 추세이므로, 국내 희귀의약품 혜택은 기대하지 않는 것이 합리적입니다.

설계안 A를 유지할 조건은 위암에서의 차별화 근거입니다. 8쪽에서 정리한 세 가지 질문(선별 기준, 링커·접합의 안전성, 치료 차수)에 비임상 자료로 답할 수 있다면 위암 단독으로도 협상이 가능합니다. 답변 자료가 준비되지 않았다면 설계안 B가 협상 상대의 범위를 넓히는 선택입니다.

■ 판정을 낮춘 요인과 종합 의견

판정을 낮춘 다섯 가지 요인 중 세 가지는 자금과 무관하게 IND 이전에 해소할 수 있습니다.

판정을 낮춘 요인

#	요인	영역
1	P1 완료까지의 자금 — 자금 총족 비율 0.38, 운영비 기준 최소 79.3억 원 부족	재무
2	위암 진입 순서 — 승인 1개·3상 ADC 2개가 선행하며, 같은 TOP01 계열 포함	시장
3	페이로드 FTO — TOP01 계열 원천 특허 보유자 존재	특허
4	ADC 제조(CMC) — 공정 변경이 제품 변경으로 이어지며, 제조 비용 미반영	규제
5	후반 단계 표본 — ADC 3상·허가 단계 표본 16건·12건	임상

동일 표적 선행 파이프라인 ● 공개 자료

자산	현황과 귀사에 대한 시사점
줄베룩시맙 단클론항체 · Astellas	FDA 승인 2024.10.18, 1차 병용, 동반진단 동시 승인. 표적 타당성을 입증한 자산이며, 1차 치료에 이미 사용되므로 귀사는 이 약 투여 이후의 환자를 설계에서 다루어야 합니다.
IBI343 ADC(TOP01) · Imovent	위암 3상 G-HOPE-001(1차 완료 예정 2026.12), 위장암 3상, 위장암 FDA 패스트트랙. 같은 페이로드 계열의 선행 자산으로 차별점 설명의 기준이 됩니다.
AZD0901 ADC · AstraZeneca	위암 2차 이상 3상 CLARITY-Gastric 01(최대 약 625명). 대형 제약사 보유 자산이며 같은 치료 차수에서 직접 경쟁합니다.

경쟁 동향 모니터링 정식판 제공

IBI343 G-HOPE-001과 AZD0901 CLARITY-Gastric 01의 결과가 공개되면 진입 순서와 경쟁 강도를 재산정해야 합니다. 정식판에서는 임상시험 등록 정보, 공시, 뉴스를 매일 확인하여 판정에 영향을 주는 변화가 있을 때 보고서를 갱신합니다.

종합 의견

LMB-201은 표적의 타당성이 입증된 시장에 후발로 진입하는 ADC입니다. 이러한 구조에서 자산의 가치는 “표적이 타당한가”가 아니라 “선행 ADC보다 우수한가”와 “이를 입증할 때까지 자금이 유지되는가”의 두 질문으로 결정됩니다. 본 보고서는 두 질문에 대해 각각 주의와 미달로 판정하였습니다.

자금 문제는 규모보다 순서의 문제로 판단됩니다.

IND까지는 여유가 있고, 시리즈A가 계획대로 진행되면 P1 전반부도 감당할 수 있습니다. 부족한 것은 P1 후반부의 두 번째 조달이며, 그 조달의 근거는 확장 코호트의 첫 반응 자료가 될 것입니다. 따라서 확장 코호트에서 어떤 자료를 몇 명으로부터 확보해야 협상과 조달을 동시에 진행할 수 있는지를 현 시점에 설계서에 명시하는 것이 자금 계획의 핵심입니다.

차별화 문제는 임상 이전에 상당 부분 해결할 수 있습니다.

선별 기준의 근거, 링커-접합의 안전성, 치료 차수 설정은 비임상 비교 자료와 설계서로 답할 수 있는 항목입니다. FTO 조사와 제조 계획 역시 자금과 무관하게 IND 이전에 문서로 정리할 수 있습니다. 판정을 낮춘 다섯 가지 요인 가운데 세 가지(FTO, 제조, 후반 단계 표본에 대한 설명)는 90일 이내에 개선할 수 있는 항목입니다.

설계안 B는 위암에서의 차별화 근거가 부족할 경우의 대안입니다. 추가 비용과 기간을 투입하는 대신 협상 상대의 범위를 넓히고 미국 개발 경로를 확보합니다. 다만 국내 희귀의약품 혜택은 기대하지 않는 것이 합리적이며, 미국 유병 자료를 확인한 이후에 결정할 것을 권고합니다.

본 보고서는 근거가 확인되지 않은 수치를 추정하여 채우지 않았습니다. 예상 매출과 위험조정 가치, 비임상 단계 전환확률, 제조비는 정식판에서 제공하며, 이 수치들이 반영되면 재무 판정의 방향은 유지되되 두 번째 조달의 필요 규모가 구체적인 금액으로 제시됩니다.

■ 분석 방법과 참고 자료

분석 방법과 참고 자료

분석 방법

업계 기준값의 적용. 성공확률, 개발 기간, 비용은 약물 분류·적응증·개발 단계가 일치하는 공개 자료를 우선 적용하였습니다. 일치하는 자료가 없으면 조건을 한 단계씩 넓혔으며, 이 경우 본문에 적용 조건을 밝혔습니다.

출처가 다른 수치의 처리. 서로 다른 모집단이나 산정 방식에서 나온 수치는 곱하거나 평균하지 않고 나란히 제시하였습니다. 원화와 달러 금액도 합산하지 않았습니다.

판정 기준. 각 영역의 판정은 사전에 정한 기준(예: 자금 충족 비율 1.5 이상 양호, 1.0 미만 미달)에 따라 부여하였으며, 여섯 영역을 합산한 종합 점수는 산정하지 않았습니다.

근거가 없는 수치. 공개 근거가 확인되지 않은 수치는 추정하여 채우지 않았습니다.

정식판 보고서에서 추가되는 분석

본 예시 보고서는 현재 개발 중인 서비스의 초기 버전(MVP)을 기준으로 작성되었습니다. 정식판에서는 다음 분석이 추가되어 제공될 예정입니다.

자산 가치	예상 최대 매출, 연도별 매출, 위험조정 순현재가치 (rNPV), IND·P1 완료 시점의 가치 상승 폭
자본 구조	RCPS 전환·리픽싱·상환 조건을 반영한 시리즈A 희석률과 상환 부담
통합 자금 계획	제조비·기관 비용을 포함한 원화 기준 필요 자금, 모집 지연을 반영한 자금 충족 비율
개발 단계 확률	비임상→P1 전환확률, 설계 요소(대조군·평가변수·대상자 수)별 성공확률 보정
규제·특허 심화	미국 희귀의약품 지정 판단, 가속승인 시나리오 가치, 특허 존속기간 연장 반영
경쟁 동향 알림	경쟁 임상 결과·허가·기술이전 발생 시 판정 재산정과 보고서 갱신

참고 문헌·공개 자료 ●

임상	BIO, Informa Pharma Intelligence, QLS Advisors. Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020. 2021.
임상	Wong CH, Siah KW, Lo AW. Estimation of clinical trial success rates and related parameters. Biostatistics. 2019;20(2):273–286.
재무	DiMasi JA, Grabowski HG, Hansen RW. Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs. J Health Econ. 2016;47:20–33.
재무	Paul SM, et al. How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. Nat Rev Drug Discov. 2010;9:203–214.
재무	Sertkaya A, Berger C, et al. (ERG for ASPE, U.S. HHS). 미국 임상시험 비용 분석 보고서. 2024.
시장	보건복지부·중앙암등록본부. 2022년 국가암등록통계. 2024.12.
시장	국민건강보험공단. 제25회(C25) 건강보험 진료현황 2016–2020. 2022.4(데일리팜 보도).
시장	Shitara K, et al. Global prevalence of CLDN18.2 in advanced gastric/GEJ adenocarcinoma (SPOTLIGHTGLOW). Gastric Cancer. 2024.
시장	U.S. FDA. FDA approves zolbetuximab-clz b with chemotherapy for gastric or GEJ adenocarcinoma. 2024.10.18.
시장	Innovent Biologics. IBI343 FDA Fast Track Designation for advanced pancreatic cancer. 2024.6.12.
시장	ClinicalTrials.gov. NCT06238843 (G-HOPE-001, IBI343 Phase 3). 2026.5 갱신.
시장	AstraZeneca. CLARITY-Gastric 01 (AZD0901 Phase 3) 연구 개요, NHS HRA; ESMO GI 2024 Abstract 495TIP.
시장	금융감독원 전자공시(DART). 리가켄바이오 기술이전 계약 공시(2023.12, 2024.10).
규제	식품의약품안전처. 「희귀의약품 지정에 관한 규정」 개정 (행정예고 2025.12.4).
규제	42 U.S.C. § 262(k)(7) — 생물의약품 기준제품 독점 기간.
규제	약사법 — 신약 재심사(자료보호) 기간.
규제	U.S. FDA. Expedited Programs for Serious Conditions (Fast Track, Breakthrough, Accelerated Approval, Priority Review).
특허	특허청 KIPRIS, WIPO 국제특허분류(IPC). 부요 해설.
특허	부요 자체 조사. ADC 링커-접합-페이로드 원천 특허 보유 현황 (공개 특허·기업 공시 기반). 2026.

예시 보고서 안내 — 본 보고서의 회사, 자산, 재무, 설계, 특허 정보는 가상으로 구성하였습니다(○). 비교 기업 재무 분위값과 동일 적응증 임상시험의 대상자 수 분포는 예시 수치입니다(◇). 공개 문헌·통계 수치(●)는 실제 출처의 값입니다.